

Servizio Sanitario Spagnolo

Il sistema sanitario spagnolo è stato istituito con Ley General de Sanidad (LGS) nel 1986 e perfezionato dalla Ley General de Salud Pública (LGSP) del 2012. Al vertice di questo sistema c'è il Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con funzioni di indirizzo generali.

L'Istituto Nacional de la Salud (INSAUD) sovrintende a tutte le attività sanitarie su una popolazione di circa 40 milioni, di cui un 17% di sessanta anni e più, quindi con un tasso di invecchiamento della popolazione in linea con la tendenza propria dei paesi sviluppati. La mortalità infantile è tra le più basse d'Europa.

Il sistema di finanziamento ha subito dei forti cambiamenti negli ultimi 20 anni. Il sistema spagnolo presenta molti tratti comuni con quello italiano tanto che si parla di sistemi gemelli.

Si era partiti con un finanziamento fondato sui contributi obbligatori versati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro, oggi invece i fondi sono reperiti a mezzo della fiscalità generale. L'effettiva implementazione di un modello universalistico è però databile solo dal 2012.

Forte è il peso in Spagna delle istanze regionali, tanto da influenzare la stessa organizzazione sanitaria che si fonda sulle Comunità Autonome, suddivise a loro volta in distretti geografici e demografici chiamati Areas de Salud (AS) che sono l'equivalente delle nostre ASL. Ogni Area de Salud ha un bacino che va dai 200.000 ai 250.000 abitanti.

Tutti i servizi sanitari sono garantiti dalle strutture pubbliche oppure forniti dai privati convenzionati, ma è proprio a partire dalle autonomie territoriali che si determinano alti livelli di disuguaglianza assistenziale. Sono privati sia quelli che perseguono finalità di lucro sia le associazioni religiose ed umanitarie.

Va precisato che dietro la facciata "umanitaria", "religiosa", "Onlus", "Croce Rossa" ecc. operano vere e proprie imprese capitalistiche, fenomeno questo già ampiamente sperimentato anche in Italia.

Accanto alla protezione generale, rimane un margine per l'intervento dell'assicurazione contro le malattie che interessa il 7% della popolazione.

Circa il 49% della spesa sanitaria è a favore delle strutture ospedaliere. Degli 804 ospedali presenti sul territorio, è pubblico il 43% mentre i restanti sono gestiti dai privati.

La dimensione degli ospedali pubblici è mediamente più grande di quelli privati e sono attrezzati ad eseguire interventi complessi sia di chirurgia che di medicina.

L'altra quota significativa di spesa è quella farmaceutica, che pesa per il 18%.

Il 66% della spesa è a bilancio statale, il 20% è coperta dalla previdenza sociale e solo il 5% è da considerarsi spesa diretta.

Però nel corso degli anni si sono avute diverse riforme che hanno portato ad un concorso di spesa diretta da parte degli utenti attraverso il meccanismo dei Ticket (copago) sui farmaci. La spesa sanitaria out-of-pocket che si è venuta a determinare, pur in presenza di un impianto universalista proprio dei sistemi Beveridge, pone

la spesa sostenuta dallo Stato sul totale della spesa sanitaria al 72,5%, dato che è inferiore all'Italia che è al 77% e al Regno Unito 82%.

Progressivamente nella sanità pubblica ha preso campo una gestione di stampo "manageriale" finalizzata (almeno così veniva narrato) al contenimento dei costi sanitari.

Anche in Spagna, come in Italia, a bilanciare la svolta che assegna il primato all'equilibrio finanziario e non alla salute, sono stati introdotti i LEA, chiamati Cartera de Servicios Comunes.

Il medico di base esercita una funzione di filtro per l'accesso alla medicina specialistica, infatti tutti devono avere un proprio medico d'elezione, che non è facile cambiare.

Nella medicina di base, i medici avrebbero dovuto gestire i centri sanitari di una precisa area geografica e servire un'utenza variabile dai 5.000 ai 30.000 utenti.

L'avrebbe è d'obbligo perché molto di quanto promesso rimane sulla carta come un enunciato di circostanza.

Nello stabilire un parallelismo con la sanità italiana, è facile osservare che i processi capitalistici operano come una forza livellatrice anche in campo sanitario senza riguardo a storia, specificità e tradizioni culturali.

Nel sistema spagnolo si distinguono due livelli di intervento.

Il primo livello è garantito dal Centre d'Atenció Primària (CAP) con un servizio di Pronto Soccorso e Ambulatoria che rispondono alle chiamate 24 ore su 24.

Ai centri si affianca anche la figura del medico di base ossia il Medico de Cabecera. Va ben inteso che una cosa è la progettualità propagandata, mentre altra è la realtà.

Se si considera la progettualità in astratto del sistema spagnolo dovremmo dire che, per quanto riguarda la medicina di base e l'assistenza primaria, si è di fronte a uno degli esperimenti più riusciti.

Con il lancio nel 1988 del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) viene posto in essere l'ambizioso tentativo di integrare la prevenzione con il più generale impegno sanitario.

Non si può dire che non si sia pensato in grande e non si sia pensato correttamente.

L'aver considerato e progettato la preservazione della salute come livello primario per prevenire e contenere le malattie, e tra queste giusto le epidemie, è un merito che va riconosciuto.

Il secondo livello è quello dell'Assistenza Specialistica che si attua con gli ospedali, le cliniche e i poliambulatori sia pubblici che privati.

Anche per il personale sanitario le somiglianze con l'Italia sono puntuali. Il personale medico è sovrabbondante, a fronte di una carenza marcata degli altri operatori sanitari a partire dagli infermieri.

A differenza della situazione italiana, In Spagna non venne attuato il numero chiuso per accedere ai corsi di medicina e anche il trattamento economico è alto ed in linea con il trattamento di favore riservato agli statali.

Per il personale infermieristico, che è alle dipendenze dello stato, la carenza si segnala soprattutto d'estate, perché in concomitanza delle ferie entra in crisi la copertura dei turni.

Mediamente gli stipendi del settore privato, come in Italia, sono più bassi di quelli del settore pubblico.

Il processo di regionalizzazione dei servizi sanitari sta realizzandosi solo in parte, infatti solo sei regioni riescono ad attuare una assistenza sanitaria integrale: Catalogna, Province Basche, Andalusia, Valencia, Navarra e Galizia. Il resto del territorio nazionale (42%) è gestito direttamente dallo Stato con l'Istituto Nazionale di Sanità di Madrid (INSALUD).

La Catalogna, e Barcellona in particolare, è proiettata verso gli standard sanitari europei, con il ruolo centrale assegnato agli ospedali a gestione privata. Questa regione assorbe il 25% della spesa sanitaria mentre la media nazionale è appena del 12%. A Barcellona, il 70% degli ospedali è privato. Si può dire che la Catalogna fa da battistrada in Spagna, come la Lombardia in Italia.

Dal 2002 le regioni che hanno pienamente realizzato l'autonomia gestionale hanno ricevuto anche un corrispondente budget dalle casse statali.

La spesa sanitaria della Spagna è intorno al 9% del PIL, al di sotto della Germania (10,5%) e della Francia (11,2%) e leggermente superiore all'Italia (8,7%).

I posti letto disponibili ogni 1.000 abitanti collocano la Spagna in posizione molto arretrata, praticamente all'ultimo posto tra i paesi più avanzati. La pubblicistica ufficiale e filogovernativa ribalta il significato di questo dato, lasciando intendere che esso dimostrerebbe un impiego razionale del personale, capace di assorbire senza danno i tagli che invece colpiscono gli altri sistemi sanitari. "Furbi" loro, che hanno provveduto per tempo....!?

La spesa sanitaria pro capite della Spagna è di 2.451 euro (a fronte di una media Ocse di 2.572 euro) con un gap rispetto ad alcuni Paesi di riferimento come Francia (3.664) e Germania (4.504), ma sostanzialmente in linea con l'Italia che si attesta su 2.473 euro.

Con la crisi finanziaria del 2008 si sono attuate politiche di rigore: tagli di personale e di strutture, su un corpo già di per sé snello per posti letto e con un personale per lo più in età avanzata.

La breccia utilizzata per minare dalle fondamenta un impianto sanitario universalista e progressista è l'articolo 90 della Ley General de Salud Pública (LGSP) che consente il trasferimento delle attività ai privati a condizione che non vi sia sottoutilizzazione di risorse pubbliche.

Si è inaugurata così la pratica del "concerto", che ha permesso ogni anno il trasferimento di 8 miliardi dai centri pubblici, tutt'altro che ottimizzati, alle tasche dei privati.

In trent'anni, nessuno dei meravigliosi giudici ha avuto da sollevare dubbi sulla liceità delle operazioni e non può sfuggire a chi legge di cose italiane che *concerto* e *concertazione* appartengono alla stessa area semantica in uso tra i riformisti di tutte le specie.

I progetti finanziari (come in Italia) hanno progressivamente cannibalizzato la sanità pubblica adottando la formula "collaborazione pubblico-privato", dove il pubblico mette i soldi e il privato gode i frutti, azzerando così il classico rischio d'impresa.

Il quadro odierno è sintetizzabile nel report apparso sul sito El Salto, sito d'area progressista che ha però coerentemente condotto una battaglia contro le privatizzazioni, dove viene descritto come il sistema sanitario sia collassato sotto l'incendio della pandemia. L'articolo "*Le cause nascoste della privatizzazione della salute in Spagna*" elenca:

"...il drammatico aumento delle liste di attesa chirurgiche e diagnostiche a livelli mai visti prima, la crescita esponenziale delle assicurazioni private, gli scambi continui delle azioni degli ospedali privatizzati, il peggioramento programmato dell'assistenza sanitaria, i tagli del personale, la riduzione dei finanziamenti destinati ai centri di gestione diretta... Era chiaro che qualsiasi aumento delle esigenze sanitarie della popolazione avrebbe causato il collasso e la mancanza di risposta da parte del sistema sanitario, come poi si è verificato".

Stiamo parlando della Spagna ma è come si parlasse dell'Italia.

Per Tolstoj: Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, ma al tempo del capitalismo che tutto livella, dovremmo dire: tutte le sanità infelici sono uguali e di quelle felici non vi è traccia!

Genova 28.01.2022